

ΟΞΥ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Γενικά: Ως Διάρρροια ορίζεται η ημερήσια αποβολή κοπράνων μάζας > 200 gr, ασχέτως της σύστασης των κοπράνων ή της συχνότητας των κενώσεων. Παρόλα αυτά, ένας χρήσιμος ορισμός αφορά σε αριθμό > 3 χαλαρά σχηματισμένων κενώσεων στη διάρκεια του 24ώρου.

- **Οξεία διάρρροια:** Ορίζεται κάθε επεισόδιο διαρροιών που έχει τυπική διάρκεια μικρότερη των 15 ημερών και προκαλείται συχνότερα από λοιμογόνους παράγοντες (π.χ. οξείες εντερικές λοιμώξεις, χολέρα, τροφικές δηλητηριάσεις) ή χημικά αίτια (π.χ. αρσενικό, υδράργυρος, κ.ά).
- **Επιμένουσα διάρρροια:** Τα διαρροϊκά επεισόδια έχουν διάρκεια περίπου 15-30 ημέρες.
- **Χρόνια διάρρροια:** Τα επεισόδια διαρροιών έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από 4 εβδομάδες και μπορεί να οφείλεται σε δομικές ή λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος.
- **Νοσοκομειακή διάρρροια:** Αφορά στην εμφάνιση τριών ή περισσότερων υδαρών κενώσεων εντός 24ώρου, οι οποίες ξεκινούν τουλάχιστον 72 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Ιστορικό: Ιδιαίτερη σημασία έχει η ηλικία του ασθενούς. Αξιολογούμε το προηγούμενο παθολογικό και χειρουργικό ιστορικό του ασθενούς [π.χ. αν συνυπάρχει απώλεια βάρους ή αν μια παρατηρούμενη απώλεια βάρους σχετίζεται με δυσαπορρόφηση, υπερθυρεοειδισμό, φλεγμονή (εντερίτιδα ή κολίτιδα), σύνδρομο Zollinger-Ellison ή κάποια κακοήθεια, κ.λπ.]. Διερευνούμε αν υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας με ίδια συμπτώματα. Ελέγχουμε τις διατροφικές συνήθειες, για πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό ιδίως σε αναπτυσσόμενη χώρα.

- * Ερευνούμε αν πρόκειται για απλή διάρρροια ή υπάρχουν συνοδά σημεία ή συμπτώματα (Πυρετός, αίμα, βλέννη, έμετος, κοιλιακό άλγος, λευκοκυττάρωση στη γενική αίματος).
- * Ελέγχουμε αν ο ασθενής λαμβάνει άλλα φάρμακα (αντιβιοτικά, καθαρικά, θυρορμόνη).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Χορηγούμε άμεσα, 50 gr ενεργού άνθρακα (fl. Toxicarb 200 mg/ml) διαλυμένο σε νερό ή 2-4 tbs. Carbosylane (po). Αποφεύγουμε όμως αυτό το βήμα σε παιδιατρικό ασθενή.
2. Εάν οι διαρροϊκές κενώσεις είναι περισσότερες από 6-8 ημερησίως ή αν πρόκειται για ασθενή ακραίας ηλικιακής ομάδας ή ασθενή με κακή κλινική εικόνα, τότε τοποθετούμε φλεβική γραμμή με 1 lt N/S, R/L ή R/S, για την αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών.
3. Επί ναυτίας και εμέτων, σε 100 ml N/S ενίουμε 1 amp. **Primperan** ή/και 1 amp. **Onda** ή αλλιώς 1 amp. **Vomex-A** (im) και μετά από 15 λεπτά χορηγούμε ενεργό άνθρακα (po).
4. Αν εκτός της διάρροιας αναφέρονται και πολλαπλοί έμετοι, τότε σε 1000 ml NaCl 0,9% προσθέτουμε 1-2 amp. **KCl**, για πρόληψη και διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών.
5. Χορηγούμε **Nifuroxazide** [10 ml syr. Ercefuryl (po) ή 2 caps. Ercefuryl 200 mg (po)], ή **Rifaximin** (2 tbs. Rifacol 200 mg) ως δόση εφόδου. Αμφότερα τα σκευάσματα αυτά παρουσιάζουν ελάχιστη συστηματική απορρόφηση από τον εντερικό σωλήνα.
6. Χορηγούμε προβιοτικά (Lactobacillus), αφού έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε παιδιά και ενήλικες, ήτοι: caps. **Ultra-Levure** 250 mg, 1x1 ή 1x2 (po), για 5 ημέρες.
7. Σε ακραίες ηλικίες και επί αιματηρής διάρροιας που συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, τοξικά φαινόμενα και διαταραχές των ηλεκτρολυτών, πρέπει να υποπτευόμαστε βάσιμα την περίπτωση Σαλμονέλλωσης και την ανάγκη νοσηλείας ή/και την έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής, μέχρι τη λήψη των αποτελεσμάτων των καλλιιεργειών κοπράνων.

Αγωγή κατ' οίκον:

1. Δίδεται Νιφουροξαζίδη (**Ercefuryl**), η οποία έχει αντιδιαρροϊκή και αντιβιοτική δράση ή Ριφαξιμίνη (**Rifacol**) επί λοιμώδους διάρροιας (Α/Δ) ή ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (Η/Ε):
 - syr. Ercefuryl: 1 κουταλιά σούπας / 8ωρο, ή caps. Ercefuryl 200 mg, 1x3 ή 1x4 x5d.
 - tab. Rifacol 200 mg, 1x4 x5d (επί Α/Δ) & tab. Rifacol 200 mg, 2x3 x7d (επί Η/Ε).ή τέλος Λοπεραμίδη (**Imodium**) εφόσον η διάρρροια δεν εμφανίζει τοξινικά και λοιμώδη χαρακτηριστικά (π.χ. πυρετός > 38,5 °C, κοιλιακό άλγος, αίμα και βλέννη στα κόπρανα):

- tab. Imodium 2 mg. Δόση φόρτισης 2x1, κι έπειτα 1x1 μετά από κάθε υδαρή κένωση.
2. Σε οξεία διάρροια που αποδίδεται σε **Ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα**, λόγω προηγθείσας λήψης αντιβιοτικών, χορηγείται Μετρονιδαζόλη (**Flagyl**) tabs. 500 mg 1x3, (per os) για 10-14 ημέρες. Εναλλακτικά, σε βαριές περιπτώσεις, χορηγείται Βανκομυκίνη (**Voncon**) sol. 125 mg 1x4, po, για 10-14 ημέρες. Στις περιπτώσεις αυτές, ιδιαιτέρως επωφελής έχει φανεί η συγχορήγηση Προβιοτικών, ήτοι caps. **Ultra-Levure** 250 mg, 1x1 x 10 ημέρες.

Εφόσον, η οξεία διάρροια αποδοθεί σε Ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα (π.χ. λόγω προηγθείσας λήψης αντιβιοτικής θεραπείας - ειδικά 2^{ης} και 3^{ης} γενεάς Κεφαλοσπορίνες, Κλινδαμυκίνη και Φθοριοκινολόνες, σε ασθενή που εξήλθε από νοσοκομείο, σε ασθενή σε οίκο ευγηρίας ή άλλο ίδρυμα, σε κατάχρηση PPIs ή H₂ αναστολέων, κ.λπ.), τότε εάν η συνδρομή δεν είναι σοβαρή - κι εφόσον είναι εφικτό - αποφεύγεται η χορήγηση **Βανκομυκίνης** po [ή η υψηλού κόστους **Φιδαξομυκίνη** (tbs. Difclir 200 mg, 1x2 για 10 ημέρες)] διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιλογής ανθεκτικών στην Βανκομυκίνη εντεροκόκκων ή άλλων ανθεκτικών μικροβίων στα κόπρανα.

3. Επί **σαλμονελλικής εντερίτιδος** και εφόσον ο ασθενής μας πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
- δεν έχει υψηλό πυρετό,
 - δεν λαμβάνει χρονίως κορτικοστεροειδή
 - δεν είναι τοξικός ή σηπτικός,
 - δεν φέρει ξένα σώματα ή μόσχευμα,
 - δεν είναι ανοσοκατασταλμένος,
 - είναι ηλικίας < 50 ετών,
- τότε, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, δεν χορηγούνται αντιβιοτικά, διότι σε εναντία περίπτωση παρατείνεται η φορία των σαλμονελλών στα κόπρανα του ασθενούς.
- Εφόσον όμως αποφασιστεί αντιμικροβιακή θεραπεία, τότε χορηγούνται από το στόμα:
- ✓ **Co-trimoxazole** 960 mg, 1x2 για 10 ημέρες (ιδίως επί ευαίσθητου στελέχους), ή
 - ✓ **Ciprofloxacin** 500 mg, 1x2 ή **Ofloxacin** 200 mg, 1x2, αμφότερα για 7-10 ημέρες, ή
 - ✓ **Pefloxacin** 400 mg, 1x2 για 7-10 ημέρες ή **Doxycycline** 100 mg, 1x2 για 10 ημέρες.

Εάν το αίτιο της Λ/Δ είναι το **E. coli O157:H7** δεν πρέπει να δίδεται αντιβιοτική αγωγή, διότι αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης **Αιμολυτικού - Ουραιμικού Συνδρόμου (HUS)**, το οποίο εκδηλώνεται με οξεία νεφρική βλάβη, θρομβοπενία και αιμολυτική αναιμία.

4. Στην περίπτωση που η οξεία διάρροια συνυπάρχει με πολλαπλά επεισόδια εμέτων, τότε πιθανότητα πρόκειται για τοξινική τροφική δηλητηρίαση (Staph. aureus, Bacillus cereus) ή πρόκειται για συνήθη ιογενή λοίμωξη (ιοί: Norwalk, Rotavirus), οπότε δεν απαιτείται αντιβιοτική αγωγή, παρά μόνον συμπτωματική θεραπεία και επαρκής ενυδάτωση.
5. Σε οξείες διάρροιες, σε βρέφη και μικρά παιδιά, συμπληρωματικά, μπορεί να δοθεί:
- sach. Racecadotril (**Hidrasec**) 10 mg/sach (1,5 mg/kg/δόση), 1x3 ή 2x3.
 - sach. Gelatine tannate (**Tasectan**) βρέφη: 1 φακελ./6ωρο· παιδιά: 1-2 φακελ./6ωρο.
6. **Υδρική υποστήριξη και διατροφές οδηγίες για επεισόδια διαρροιών, (βλ. σελ. 417):**
- Βρασμένο ρύζι (λαπάς). Ρυζόνερο. Βραστές πατάτες (ή purée). Βραστό κοτόπουλο.
 - Γιαούρτι, κατά προτίμηση άπαχο ή παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι με πέτσα.
 - Χυμός κομπόστας (όχι φρούτο). Χυμός μήλου ή ψητό μήλο. Μπανάνα. Βατόμουρα.
 - Τσάι με λεμόνι (3-5 ρουφηξιές ανά 30 λεπτά). Φασκόμηλο (1-2 φλιτζάνια την ημέρα).
 - Αναψυκτικά τύπου cola (όχι light ή zero), sprite ή σόδα (100-150 ml σε κάθε δόση).
 - Λευκό ψωμί (όχι ημέρας). Φρυγανιές, κράκερς, κριτσίνια, τοστ.
 - Διάλυμα **Almora** ή **Med-electrolytes** σε δόση 3-5 φακελάκια/24ωρο, για 3-4 ημέρες.

Αποφεύγουμε: Λιπαρά φαγητά, τηγανητά, σάλτσες, φρούτα, πράσινα λαχανικά, φυτικές ίνες, γλουτένη, γαλακτοκομικά προϊόντα, αλκοόλ, καρυκεύματα ή καυτερά/πικάντικα φαγητά, κ.λπ.

Ένα πρακτικό διάλυμα ηλεκτρολυτών, που παρασκευάζεται εύκολα, κατ' οίκον, είναι:

- 2-4 κουταλιές της σούπας **ζάχαρη** (γλυκόζη).
- 1 κουταλάκι του γλυκού **αλάτι** (NaCl).
- 1 κουταλάκι του γλυκού **μαγειρική σόδα** (Διττανθρακικά - Na₂CO₃).
- 1 κύπελλο (100-200 ml) **χυμό μπανάνας ή πορτοκάλι** (K⁺/Ca⁺⁺/Mg⁺⁺).
- 100 - 200 ml εμφιαλωμένο ή βρασμένο **νερό**.

